

1. Introducción y relevancia clínica

Los **trastornos de la personalidad (TP)** son **patrones persistentes de experiencia interna y comportamiento** que se desvían de las expectativas socioculturales, son **inflexibles y desadaptativos**, y causan **deterioro funcional significativo o malestar subjetivo**.

Se inician habitualmente en la **adolescencia o adultez temprana** y tienden a ser **crónicos**.

A diferencia de otros trastornos psiquiátricos, **no son episódicos** (como la depresión o la esquizofrenia), sino **rasgos permanentes del modo de pensar, sentir y relacionarse**.

En Chile, se estima una prevalencia de **6–10% en población general**, siendo los más comunes:

- **Trastorno límite de la personalidad (TLP)**
- **Trastorno antisocial**
- **Trastorno evitativo y obsesivo-compulsivo de la personalidad**

□ En el **EUNACOM**, este tema aparece con frecuencia en forma de casos clínicos donde se evalúa la capacidad del médico para:

- Reconocer patrones conductuales persistentes (no crisis agudas).
- Diferenciar trastornos de personalidad de trastornos afectivos o psicóticos.
- Indicar derivación psiquiátrica y manejo psicoeducativo adecuado.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Bases psicodinámicas y biológicas

Los TP derivan de una **interacción entre factores genéticos, temperamentales y experiencias tempranas**.

Los mecanismos implicados incluyen:

- **Factores genéticos:** herencia de rasgos temperamentales (impulsividad, ansiedad, introversión).
- **Neurobiología:** disfunción de la **amígdala**, **corteza prefrontal** y **sistema serotoninérgico**.
- **Factores psicosociales:** trauma infantil, negligencia, abuso físico o emocional.
- **Aprendizaje y apego:** modelos parentales inestables o coercitivos moldean patrones de relación disfuncionales.

En conjunto, estos factores generan estilos de afrontamiento rígidos y desadaptativos ante el estrés.

2.2. Estructura diagnóstica (DSM-5 / CIE-11)

El **DSM-5** organiza los TP en **tres grupos o “clusters”**, según rasgos predominantes:

- **Cluster A:** excéntricos o raros
- **Cluster B:** dramáticos, emocionales o erráticos
- **Cluster C:** ansiosos o temerosos

La **CIE-11** (implementada por MINSAL) avanza hacia un modelo **dimensional**, centrado en la **gravedad del deterioro** y los **rasgos dominantes** (disocial, evitativo, anancástico, etc.), pero en el contexto EUNACOM se mantiene la clasificación tradicional del DSM-5.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Cluster A – Personalidades excéntricas o raras

Características generales: aislamiento social, pensamiento distorsionado, afectividad restringida.

A menudo se consideran dentro del espectro esquizofrénico.

Trastorno	Rasgos principales	Diagnóstico diferencial
-----------	--------------------	-------------------------

Paranoide	Desconfianza injustificada, suspicacia, rencor persistente, interpretación maliciosa de los actos ajenos.	Trastorno delirante (pero sin delirios estructurados).
Esquizoide	Aislamiento, desapego emocional, preferencia por actividades solitarias, indiferencia al elogio o crítica.	Depresión mayor (sin anhedonia ni tristeza profunda).
Esquizotípico	Pensamiento mágico, creencias extrañas, lenguaje o conducta excéntrica, ansiedad social intensa.	Esquizofrenia (sin pérdida de realidad completa).

□ Estos pacientes rara vez buscan ayuda; suelen llegar por presiones familiares o laborales.

3.2. Cluster B – Personalidades dramáticas, emocionales o erráticas

Características generales: impulsividad, inestabilidad emocional, conductas manipuladoras o teatralidad.

Trastorno	Rasgos principales	Diagnóstico diferencial
Antisocial	Desprecio por normas sociales, engaño, impulsividad, ausencia de remordimiento, conductas delictivas.	Trastorno por consumo de sustancias, TLP.
Límite (Borderline)	Inestabilidad afectiva, relaciones intensas e inestables, temor al abandono, conductas autolesivas, vacío crónico.	Trastorno bipolar (episodios afectivos más definidos).
Histriónico	Emocionalidad superficial, búsqueda de atención, seducción inadecuada, dramatismo.	Trastorno narcisista o trastornos del ánimo.
Narcisista	Grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía, sensibilidad extrema a la crítica.	Trastorno bipolar tipo I (episodio maníaco).

- ☐ En atención primaria, los más relevantes son el **límite y el antisocial**, por su asociación a conductas de riesgo, autolesiones y problemas legales.
-

3.3. Cluster C – Personalidades ansiosas o temerosas

Características generales: rigidez, necesidad de control, dependencia o miedo al rechazo.

Trastorno	Rasgos principales	Diagnóstico diferencial
Evitativo	Inseguridad, inhibición social, hipersensibilidad a la crítica, deseo de afecto pero miedo al rechazo.	Fobia social (más centrada en situaciones específicas).
Dependiente	Necesidad excesiva de apoyo, dificultad para tomar decisiones, miedo a la soledad o abandono.	Trastorno depresivo o ansioso.
Obsesivo-compulsivo (anancástico)	Perfeccionismo extremo, rigidez moral, control excesivo, dificultad para delegar.	Trastorno obsesivo-compulsivo (sin rituales egodistónicos).

- ☐ En APS, los **trastornos evitativo y anancástico** son frecuentes en pacientes con ansiedad crónica o somatización.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Criterios diagnósticos DSM-5 (generales para todos los TP)

Se requiere un patrón **persistente e inflexible** de experiencia interna y comportamiento que:

1. Se desvía notablemente de las expectativas culturales en ≥ 2 áreas:
 - Cognición (modo de percibir e interpretar).
 - Afectividad (rango, intensidad, estabilidad).

- Relaciones interpersonales.
 - Control de impulsos.
2. Es **estable a lo largo del tiempo y desde la adolescencia**.
 3. **Causa deterioro significativo** en el funcionamiento social o laboral.
 4. No se explica mejor por otro trastorno mental, sustancia o enfermedad médica.
-

4.2. Evaluación clínica

- **Entrevista clínica estructurada** (SCID-II, MINI).
- **Escalas de personalidad:** MMPI-2, Inventario de Millon.
- **Historia evolutiva:** infancia, relaciones familiares, estilos de afrontamiento.
- **Evaluación de comorbilidad:** depresión, ansiedad, TUS, trauma.

☐ En EUNACOM, el diagnóstico se basa en **patrón conductual persistente + deterioro funcional**.

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Principios generales

- **No existe tratamiento farmacológico específico** para los TP.
 - El manejo es principalmente **psicoterapéutico y psicoeducativo**.
 - Los fármacos solo se utilizan para **síntomas comórbidos** (depresión, ansiedad, impulsividad).
-

5.2. Psicoterapia

El tipo de terapia depende del TP predominante:

Trastorno	Terapia de elección	Objetivos
Límite	Terapia dialéctico-conductual (TDC)	Regulación emocional, reducción de autolesiones.
Antisocial	TCC + programas de reinserción social	Control de impulsividad y empatía social.
Evitativo y dependiente	TCC + terapia de apoyo	Reestructurar autoimagen y habilidades sociales.
Anancástico	TCC + relajación	Flexibilizar pensamiento y control.
Histriónico / narcisista	Psicoterapia psicodinámica o TCC	Insight sobre conductas manipulativas.

□ La alianza terapéutica puede ser difícil: es crucial establecer **límites claros** y expectativas realistas.

5.3. Farmacoterapia (sintomática)

- **ISRS:** ansiedad, impulsividad, depresión.
- **Estabilizadores del ánimo (valproato, lamotrigina):** inestabilidad afectiva en TLP.
- **Antipsicóticos atípicos (quetiapina, olanzapina):** descontrol de impulsos, ideación paranoide.
- **Ansiolíticos:** evitar uso prolongado por riesgo de dependencia.

5.4. Intervención en atención primaria

- Identificar rasgos persistentes que dificultan la adherencia o generan conflictos interpersonales.

- No etiquetar precozmente; evitar juicios morales.
- Promover adherencia al tratamiento, hábitos saludables y derivar a salud mental.
- Involucrar familia o red de apoyo.

☐ En APS, el rol principal es **detectar, contener y derivar oportunamente**.

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones

- **Riesgo suicida elevado** (particularmente en TLP).
- **Trastornos comórbidos:** depresión, ansiedad, abuso de sustancias.
- **Conflictos interpersonales, violencia doméstica o laboral.**
- **Adherencia terapéutica baja** por desconfianza o impulsividad.

6.2. Pronóstico

- Variable según tipo:
 - **TLP:** mejora significativa con terapia (>50% remisión en 10 años).
 - **Evitativo y anancástico:** buen pronóstico con psicoterapia.
 - **Antisocial y narcisista:** pronóstico reservado, alta recaída conductual.

☐ La psicoeducación y la estabilidad de la red de apoyo mejoran la evolución a largo plazo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐

Perlas clínicas

1. Los TP son **patrones persistentes**, no episodios agudos.

2. El diagnóstico requiere **inicio temprano y rigidez conductual**.
 3. El **trastorno límite** es el más frecuente y con mayor riesgo suicida.
 4. El **trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad** NO implica rituales egodistónicos.
 5. **Terapia dialéctico-conductual** es la de elección en TLP.
 6. La **farmacoterapia** es solo coadyuvante.
 7. En APS, el enfoque debe ser **de contención y derivación**, no de diagnóstico definitivo.
-



Errores comunes

- Confundir **trastorno de personalidad** con **rasgos de personalidad**.
 - Diagnosticar TP en un episodio depresivo o psicótico.
 - Esperar “curación” rápida: el tratamiento es prolongado.
 - Usar psicofármacos como única estrategia.
 - No establecer límites terapéuticos firmes con pacientes difíciles.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **trastornos de personalidad** son patrones rígidos, inflexibles y persistentes del modo de pensar, sentir y actuar.
2. Se agrupan en **tres clusters**: A (excéntricos), B (dramáticos), C (ansiosos).
3. El diagnóstico se basa en **inicio precoz, estabilidad en el tiempo y deterioro funcional**.
4. El **tratamiento es psicoterapéutico**, especialmente la **TDC** para el TLP.

5. Los fármacos se utilizan solo para síntomas comórbidos.
6. En APS, la estrategia clave es **contención, psicoeducación y derivación oportuna**.
7. El **trastorno límite** concentra el mayor riesgo suicida y demanda especial atención.